



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عايده رافت احمد عطيه
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : السيده زينب
رقم البطاقة : 27801260100089 رقم التليفون : 01005386077
العنوان : ممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-01-1978 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عايدة رافت احمد عطيه National ID: 27801260100089	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

(6/2)

جمهورية مصر العربية
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة الشخصية

عائده
رائفت احمد عطيه
٧ من عبدالملك بن بزيق قلعة الكيش
السيدة زينب - القاهرة

١٩٧٧

٢٧٨٠١٢٦٠١٠٠٠٨٩

IE2754723

٢٠١٩/١٠ ٢٧٨٠١٢٦٠١٠٠٠٨٩
حاصلة على دبلوم معهد فنّي تجارى

مفتوحة
معلمة
انثى

مضى الدين سيد عبدالجيد مضى الدين
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/١٠/٠٤



(ለጋንዳና ሌሎች የጥፋት በሽታዎች ለመቆጣጠርና ለመታወቅ)

MDT FORM

14/14/2022

Name	21-11-2010	MRN	1185/10
Age	43 y	ID	1185/10
Menopausal status		Phone	1185/10
OCP		Marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	R	K1 sm	
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	8/8		
Sonomammography:			
Mets Workup:			
multifocal cT2-N1 YPT/YPN			
Recommendations:			

Rec: AC x 4. Taxol x 4 cycles.

-> YPT1 - YPN1/4

MDT OUTCOME & PLAN

For Adjuvant HT (AL + Zolodex)

PORT

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY

Patient Name : *Wahab Ghoniem*
Patient No. : 27801260100089
Path No. : SR-465/21
Sex : Female
Age : 43 Y
Referring Doc :

Request No : 135714
Request Date : 21/09/2021
Verification Date : 28/09/2021
Financial Category : *المرضى الخارجيين*
Department : Out Patient

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer.

Nature of the specimen:
Slide revision.

Gross Examination:
One paraffin block labeled as (6718-21) and three slides were received.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis) II
- Angioinvasion: Positive
- Ductal carcinoma in situ: Minimal
- Additional pathologic findings: with micropapillary pattern
- Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 70% of the tumor cells.
- Examination of PR stained slide show intense nuclear staining in 70% of the tumor cells.
- Examination of HER2 stained slide show no staining in tumor cells.

Diagnosis:

Right breast cancer; Slide revision:

- Invasive duct carcinoma, nuclear grade II
- ER: Positive (7/8).
- PR: Positive (7/8).
- HER-2: Negative (score 0).

Prof. Dr. Aml Hareedy
Dr. Walaa Ghoniem

- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows, no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
-

OPINION:

- *Right breast malignant looking mass lesion.*
- *Right sided ground glass pulmonary nodule of indeterminate nature for follow up.*
- *No definite hepatic or osseous metastatic deposits.*

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr.m.gomaa,md

Name: *Aida Rafaat Ahmed*

Date: *15-09-2021*

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS
REVEALED: -

1. Chest:

- Right breast UIQ irregular speculated mass lesion measuring 2.7 X 2 cm.
- Middle lung lobe medial segment ground glass pulmonary nodule, measuring 8 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Enlarged thyroid gland with left thyroid lobe retro-sternal extension.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD seen insitu.
- Right adnexal cystic lesion measuring 3 cm, mostly functional in nature.
- Normal appearance of the other pelvic organs.

Patient's Name: Aida Raafat Ahmed
Date: 2026-07-19
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography

revealed:

Clinical summary: Status post right MRM

Findings:

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

•

Conclusion:-

- **Left breast (BIRADS 1): normal study.**
- **Clear right mastectomy bed and axilla.**

Dr farah elshobaky

Dr Amal Hegazy

Dr Amal Hegazy

NAME: AIDA RAFFAT

DATE: 19/7/2026

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexal; no abnormalities could be detected

Opinion:

Unremarkable study

Best regards

Dr. NERMEEN RAMADAN FEBIR, MD

Patient's Name: Aida Raafat Ahmed
Date: 2026-07-19
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography

revealed:

Clinical summary: Status post right MRM

Findings:

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

•

Conclusion:-

- **Left breast (BIRADS 1): normal study.**
- **Clear right mastectomy bed and axilla.**

Dr farah elshobaky

Dr Amal Hegazy

Dr Amal Hegazy

NAME: AIDA RAFFAT

DATE: 19/7/2026

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexal; no abnormalities could be detected

Opinion:

Unremarkable study

Best regards

Dr. NERMEEN RAMADAN FEBIR, MD